PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: evaluación sanitaria independiente de las sustancias a regular

Encarga a universidades nacionales y organismos científicos, por convenio y con garantías de independencia, una evaluación sanitaria de qué sustancias podrían tener acceso regulado bajo supervisión médica y con qué esquema, como base de la reforma de la Ley 23.737 de la Fase II; el informe es público.

Propuesta 81: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Fase I (año 1); informe final antes del inicio de la Fase II
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud y convenios con las instituciones evaluadoras. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el programa de gobierno prevé reformar la Ley N° 23.737 para que el consumo personal deje de perseguirse penalmente y para regular, bajo supervisión médica y por canales con control sanitario, el acceso a algunas sustancias.

Que la decisión sobre qué sustancias incluir y con qué esquema debe apoyarse en una evaluación sanitaria independiente, basada en la mejor evidencia disponible y sujeta a revisión periódica.

Que las universidades nacionales y los organismos nacionales de ciencia y técnica cuentan con capacidad para realizar esa evaluación con independencia de criterio.

Que encargar estudios que sirvan de base a las políticas sanitarias es una tarea propia de este Ministerio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Encárgase la realización de una evaluación sanitaria independiente de las sustancias cuyo consumo podría ser objeto de acceso regulado bajo supervisión médica, como base de la reforma de la Ley N° 23.737 que el Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. La evaluación comprende, al menos: a) los riesgos y los daños para la salud de cada sustancia, individuales y poblacionales; b) la evidencia sobre usos terapéuticos y de reducción de daños; c) los efectos esperables de distintos esquemas de acceso regulado bajo supervisión médica sobre el consumo, en especial entre adolescentes y jóvenes; d) los requisitos de control sanitario, trazabilidad y provisión exclusiva por canales con control sanitario; e) la experiencia internacional y la de los regímenes nacionales vigentes de acceso regulado a sustancias con fines medicinales; y f) la capacidad del sistema de salud para la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos.

ARTÍCULO 3°.- Instituciones evaluadoras. La evaluación se encomienda, mediante convenio, a universidades nacionales y a organismos nacionales de ciencia y técnica, que conforman un Panel de Evaluación Sanitaria Independiente integrado por especialistas en farmacología, toxicología, psiquiatría, salud pública, epidemiología y ciencias sociales. Los convenios se celebran dentro de los sesenta (60) días de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Independencia. Los integrantes del Panel suscriben una declaración pública de intereses y no pueden tener vínculos con empresas que produzcan o comercialicen las sustancias evaluadas. Este Ministerio no imparte instrucciones sobre las conclusiones de la evaluación y no puede modificar el informe.

ARTÍCULO 5°.- Información. Este Ministerio y su Secretaría de Salud Mental y Adicciones proveen al Panel la información disponible sobre consumos, tratamientos y atención, en forma anonimizada. El Panel puede requerir información a otros organismos públicos y consultar a sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 6°.- Plazos. El Panel presenta un informe preliminar a los seis (6) meses y su informe final a los diez (10) meses de la firma del convenio.

ARTÍCULO 7°.- Contenido del informe. El informe final indica, para cada sustancia evaluada, si recomienda o no su inclusión en un esquema de acceso regulado bajo supervisión médica y, en su caso, las condiciones sanitarias mínimas; propone indicadores de seguimiento y la periodicidad de revisión del esquema; e incluye las opiniones en disidencia de sus integrantes.

ARTÍCULO 8°.- Publicidad. Este Ministerio publica en forma íntegra el informe preliminar y el informe final en su sitio oficial dentro de los diez (10) días de recibidos, y los remite al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Gastos. Los gastos que demande la presente se atienden con los créditos asignados a este Ministerio en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app